Аллергический ринит

Клинические рекомендации от 11.07.2024 · взрослые и дети

Источник — клинические рекомендации Минздрава РФ, рубрикатор cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/261_2. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026. Справочник не заменяет текст рекомендации.

Коды МКБ-10

- **J30.1** Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений
- **J30.2** Другие сезонные аллергические риниты
- **J30.3** Другие аллергические риниты
- **J30.4** Аллергический ринит неуточнённый

Главное

- Диагноз ставят, когда хотя бы два из четырёх симптомов (заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в носу) беспокоят ежедневно не меньше часа, прослеживается связь с аллергеном и аллергообследование положительное.
- Лечение подбирают по ступеням. На первой назначают один препарат: антигистаминный внутрь или в нос, кромоглициевую кислоту или монтелукаст. На второй предпочтителен назальный глюкокортикостероид. На третьей к нему добавляют один-два препарата из первой ступени, а четвёртая — омализумаб, который назначает только специалист.
- Назальные глюкокортикостероиды действуют сильнее антигистаминных препаратов внутрь и кромоглициевой кислоты, особенно при выраженной заложенности.
- Сосудосуживающие капли назначают только при обострении с выраженной заложенностью и только коротким курсом, на 3–7 дней.
- Контроль оценивают по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» на первом приёме и через 2–4 недели лечения.

Клиника и классификация

Определение

Аллергический ринит — IgE-опосредованное воспаление слизистой оболочки носа, которое развивается под действием аллергенов. Хотя бы два симптома — заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в полости носа — проявляются ежедневно в течение часа и дольше.

Классификация

По причине выделяют сезонный, круглогодичный (бытовой) и профессиональный ринит. По течению — интермиттирующий, когда симптомы беспокоят меньше 4 дней в неделю или меньше 4 недель в году, и персистирующий, когда больше 4 дней в неделю и больше 4 недель в году.

При лёгком течении симптомы не мешают сну и дневным делам. При среднетяжёлом мешают работе, учёбе, спорту и нарушают сон. При тяжёлом без лечения пациент не может нормально работать, учиться и спать. Кроме того, различают обострение и ремиссию.

В диагнозе указывают аллергены, к которым выявлена повышенная чувствительность.

Отдельно выделяют локальный аллергический ринит. Симптомы типичные и чётко связаны с аллергеном, но кожные пробы и специфические IgE в крови отрицательны. Специфические IgE в носовом секрете в России не определяют, а назальные провокационные тесты положительны.

Жалобы

Основные жалобы — заложенность носа с дыханием ртом, сопением, храпом и изменением голоса; водянистые выделения; чихание, часто приступами по утрам; зуд, реже жжение в носу, иногда зуд нёба и глотки. Пациенты трут кончик носа ладонью («аллергический салют»), из-за чего появляется поперечная складка на носу. На поздних стадиях снижается обоняние.

Жалобы и анамнез собирают у каждого пациента с подозрением на аллергический ринит. При круглогодичной форме ведущий симптом — заложенность носа со слизистыми выделениями, при сезонной — приступы чихания, зуд и ринорея. Важно расспросить о связи симптомов с аллергеном и об аллергических болезнях у пациента и кровных родственников.

Из-за обильных выделений и нарушения проходимости слуховых труб бывают раздражение и отёк кожи над верхней губой и у крыльев носа, носовые кровотечения после сморкания, боль в горле и покашливание, боль и треск в ушах при глотании, снижение слуха.

При сезонном рините часто встречается оральный аллергический синдром — перекрёстная непереносимость свежих фруктов, овощей, орехов и семян. Проявления разные: от зуда во рту до анафилаксии.

Осмотр

Всем пациентам осматривают верхние дыхательные пути, проводят общий осмотр и аускультацию, чтобы не пропустить бронхиальную астму, конъюнктивит и атопический дерматит. Характерны затруднённое носовое дыхание, приоткрытый рот, тёмные круги под глазами, мацерация кожи над верхней губой, отёчность лица.

Диагностика

Диагноз ставят, когда есть характерные жалобы (два симптома из четырёх, ежедневно не меньше часа), анамнез указывает на связь с аллергеном или на другие аллергические болезни и аллергообследование положительно.

Пациента ведут вместе оториноларинголог и аллерголог-иммунолог. Оториноларинголог проводит риноскопию и эндоскопию, дифференциальную диагностику, выявляет осложнения и анатомические нарушения и определяет показания к операции. Аллерголог-иммунолог ставит кожные и провокационные тесты, оценивает их, исключает астму и решает вопрос об аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

ЛОР-осмотр

Переднюю риноскопию проводят всем. Обычно видны отёк носовых раковин и много водянистого секрета. Слизистая ярко-красная при обострении сезонного ринита и цианотичная или серая при круглогодичном, бывает «мраморной» (симптом Воячека), могут быть полипы.

Эндоскопию полости носа, носоглотки и пазух проводят, если стандартное лечение не помогает или ринит осложнённый. Проба с сосудосуживающим средством показывает, обратима ли обструкция.

Контроль симптомов оценивают по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» на первом приёме и через 2–4 недели лечения. Подробнее — в разделе «Контроль лечения».

Аллергообследование

Если противопоказаний нет, ставят кожные пробы (prick-тесты или скарификационные), чтобы подтвердить аллергическую природу ринита, найти причинные аллергены и решить вопрос об АСИТ.

Пробы ставят в аллергологическом кабинете. На результат влияют возраст младше 5 и старше 60 лет, приём системных глюкокортикоидов, антигистаминных и психотропных препаратов, дермографизм (ложноположительный результат) и недавняя острая аллергическая реакция (ложноотрицательный).

Специфические IgE в крови определяют, если кожные пробы противопоказаны или невозможны, их результат сомнителен или расходится с анамнезом.

По методу ImmunoCAP результат считается положительным при значении больше 0,70 kU/l.

Общий IgE для диагностики не назначают: он неинформативен.

Анализы

Развёрнутый общий анализ крови назначают при выраженных симптомах в обострении или перед АСИТ. Смотрят эозинофилы; лейкоцитоз со сдвигом влево — повод искать инфекцию, прежде всего острый риносинусит.

При выраженных симптомах в обострении можно сделать цитологию смывов из носа. Для аллергического ринита характерна эозинофилия носового секрета — 10% и больше.

Общий IgE определяют только перед назначением омализумаба (с 12 лет, при тяжёлом течении), потому что по нему рассчитывают дозу.

Лучевая и функциональная диагностика

Рентгенографию пазух делают при симптомах риносинусита (гнойные выделения, боль в проекции пазух, головная боль, температура) или при лейкоцитозе со сдвигом влево.

КТ пазух нужна, если лечение не помогает, обструкция выраженная и длительная, держится аносмия или аллергообследование отрицательное. Прежде всего её делают при подозрении на полипозный риносинусит.

Спирометрию с бронхолитиком проводят при кашле, свистящем дыхании и одышке, а также перед АСИТ, чтобы выявить скрытый бронхоспазм.

Перед инъекционной АСИТ записывают ЭКГ.

Дифференциальная диагностика

Аллергический ринит отличают от инфекционного ринита, аномалий внутриносовых структур, аденоидов у детей и полипозного риносинусита. Его отличают и от неаллергических ринитов: эозинофильного, лекарственного (НПВП, альфа- и бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, резерпин, долгий приём деконгестантов), гормонального (беременность, пубертат, менструальный цикл, контрацептивы, акромегалия, гипотиреоз), профессионального, атрофического ринита пожилых, пищевого и алкогольного, идиопатического. Кроме того, исключают первичную цилиарную дискинезию и муковисцидоз.

Лечение

Цель лечения — полный контроль симптомов. Если контакт с аллергеном, табачным дымом или другими раздражителями продолжается, можно добиться лишь уменьшения симптомов.

Ступени лечения

На любой ступени исключают контакт с аллергеном, при показаниях оперируют сопутствующую патологию и рассматривают АСИТ.

Ступень	Назначения
1-я ступень	Один препарат: антигистаминный внутрь без седативного эффекта, антигистаминный спрей в нос, кромоглициевая кислота в нос или монтелукаст.
2-я ступень	Один препарат, предпочтительно назальный глюкокортикостероид; можно антигистаминный внутрь или в нос либо монтелукаст.
3-я ступень	Назальный глюкокортикостероид вместе с одним или несколькими препаратами: антигистаминным внутрь или в нос, монтелукастом.

Ступень	Назначения
4-я ступень	Омализумаб при тяжёлом течении, с 12 лет. Назначает только специалист.
Для быстрой помощи	Сосудосуживающие капли коротким курсом или глюкокортикоиды внутрь.

> Прежде чем переходить на ступень выше, перепроверьте диагноз, приверженность лечению, сопутствующие болезни и анатомические аномалии.

Антигистаминные препараты внутрь

Антигистаминные препараты без седативного эффекта назначают всем пациентам: они уменьшают зуд, чихание, ринорею и заложенность. Цетиризин в больших дозах вызывает сонливость чаще остальных.

Седативные антигистаминные первого поколения не назначают: они вызывают сонливость, нарушают сон и могут приводить к апноэ во сне.

Препарат	Доза
Дезлоратадин	Взрослым и детям с 12 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 2,5 мг, детям 1–5 лет — 1,25 мг, детям 6–12 месяцев — 1 мг 1 раз в сутки.
Левоцетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки.
Лоратадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–12 лет при весе до 30 кг — 5 мг, больше 30 кг — 10 мг 1 раз в сутки.
Фексофенадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 120 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 30 мг 2 раза в сутки.
Цетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5–10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–6 лет — 2,5 мг 2 раза или 5 мг 1 раз в сутки, детям 1–2 лет — 2,5 мг 2 раза в сутки, детям 6–12 месяцев — 2,5 мг 1 раз в сутки.
Эбастин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10–20 мг 1 раз в сутки. Есть форма для рассасывания под языком.
Рупатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки.
Биластин	Взрослым и детям старше 12 лет — 20 мг 1 раз в сутки.

Назальные глюкокортикостероиды

Их назначают при среднетяжёлом и тяжёлом течении, особенно при выраженной заложенности. Они сильнее антигистаминных препаратов внутрь и кромоглициевой кислоты и помогают также при глазных симптомах. Возможны сухость, носовые кровотечения, редко перфорация перегородки, поэтому пациента нужно научить правильно вводить спрей.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Мометазон	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддержки — 1 доза; при необходимости до 4 доз. Детям 2–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Флутиказона фуроат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (55 мкг) 1 раз в сутки, для поддержки — 1 доза. Детям 2–12 лет — 1 доза (27,5 мкг) 1 раз в сутки, при необходимости 2 дозы.
Флутиказона пропионат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддержки — 1 доза. Детям 4–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Будесонид	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки, для поддержки — 200 мкг в сутки. Не дольше 3 месяцев.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Беклометазон	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки, это максимальная доза; для поддержки — 1 доза 2 раза в сутки.

Антигистаминные спреи и комбинации

Антигистаминные спреи быстро уменьшают симптомы, в течение 30 минут. Их назначают отдельно или вместе с другими препаратами; возможна сухость слизистой.

Если нужны и антигистаминный, и гормональный спрей, удобнее назначить один комбинированный.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Азеластин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза (0,14 мг) 2 раза в сутки, с 12 лет при необходимости 2 дозы. Не дольше 6 месяцев.
Левокабастин	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы 2 раза в сутки, при выраженных симптомах 3–4 раза. Если за 3 дня эффекта нет, препарат отменяют.
Азеластин и флутиказон	Взрослым и детям старше 12 лет — 1 доза (137 мкг азеластина и 50 мкг флутиказона) 2 раза в сутки.
Азеластин и мометазон	Взрослым с 18 лет — 1 доза (140 мкг азеластина и 50 мкг мометазона) 2 раза в сутки, курс 2 недели.
Мометазон и олопатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы 2 раза в сутки (в КР указано 50 мкг мометазона и 1200 мкг олопатадина). Детям 6–11 лет только при сезонном рините — 1 доза (25 и 600 мкг) 2 раза в сутки.

Монтелукаст и кромоглициевая кислота

Монтелукаст можно назначать при любой тяжести, отдельно или вместе с другими препаратами, но он слабее назальных глюкокортикостероидов.

Если у пациента ещё и бронхиальная астма, монтелукаст помогает контролировать обе болезни. Курс — от 1 до 3 месяцев и дольше; по инструкции ограничений по длительности нет.

Если нужны и антигистаминный препарат внутрь, и монтелукаст, можно назначить комбинированную таблетку левоцетиризина с монтелукастом.

Кромоглициевую кислоту в нос назначают при лёгком течении. Она безопасна, но слабее антигистаминных препаратов, монтелукаста и назальных глюкокортикостероидов.

Препарат	Доза
Монтелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 10 мг 1 раз в сутки, детям 6–15 лет — 5 мг, детям 2–6 лет — 4 мг (жевательная таблетка) 1 раз в сутки.
Левоцетиризин и монтелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 1 таблетка (5 мг и 10 мг) 1 раз в сутки.
Кромоглициевая кислота, спрей	Взрослым и детям старше 5 лет — 1 доза в каждый носовой ход 4 раза в сутки, при необходимости до 6 раз. Когда наступит эффект, можно применять только при контакте с аллергеном. Курс 4 недели.

Сосудосуживающие препараты

При обострении с выраженной заложенностью их назначают коротким курсом, на 3–7 дней.

Длительные курсы не назначают: после 10 дней развиваются привыкание, отёк слизистой и медикаментозный ринит.

Если нужны и антигистаминный, и сосудосуживающий препарат в нос, можно назначить комбинацию диметиндена с фенилэфрином, не дольше 7 дней.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Оксиметазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы 0,05% раствора 2–3 раза в сутки. Детям 1–6 лет — 1–2 капли 0,025%, детям от 5 недель до года — 1–2 капли 0,01%, до 4 недель — 1 капля 0,01% 2–3 раза в сутки. Курс 3–4 дня.
Ксилометазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза 0,1% раствора 1–3 раза в сутки, детям 2–6 лет — 1 доза 0,05% 1–2 раза в сутки. Не дольше 5–7 дней.
Диметинден и фенилэфрин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы спрея или 3–4 капли 3–4 раза в сутки. Детям 1–6 лет — только капли, по 1–2 капли 3–4 раза в сутки.

Тяжёлое течение

При тяжёлом обострении или если третья ступень не помогает, можно назначить короткий курс глюкокортикоидов внутрь.

Это четвёртая линия или лечение тяжёлого обострения. Вводить растворы и депо-формы глюкокортикоидов в носовые раковины недопустимо: это грозит тяжёлыми осложнениями вплоть до слепоты. Дозу преднизолона, метилпреднизолона или дексаметазона подбирают индивидуально; преднизолон в таблетках противопоказан детям до 3 лет.

Депо-формы глюкокортикоидов не назначают: побочные эффекты развиваются быстро, вплоть до надпочечниковой недостаточности.

Омализумаб рассматривают с 12 лет при тяжёлом персистирующем течении или тяжёлом обострении, если третья ступень не помогает.

Его вводят подкожно раз в 2 или 4 недели, доза от 75 до 600 мг — по таблице дозирования. При сезонном рините начинают хотя бы за неделю до начала пыления и продолжают до его окончания.

Без лекарств

Всем пациентам рекомендуют по возможности избегать контакта с аллергеном. Даже частичное ограничение облегчает течение и снижает потребность в лекарствах.

Всем рекомендованы изотонические солевые растворы для носа, в том числе на основе морской воды.

Перед введением назального глюкокортикостероида нос промывают: так препарат лучше контактирует со слизистой, а сухость и кровотечения возникают реже.

Аллерген-специфическая иммунотерапия

АСИТ рассматривают у всех пациентов в ремиссии, в том числе медикаментозной. Она уменьшает симптомы и потребность в лекарствах, предупреждает развитие астмы и расширение спектра аллергенов.

Показания, противопоказания и выбор аллергена определяет аллерголог-иммунолог, он же назначает АСИТ.

Хирургическое лечение

Операцию проводят только при сопутствующей патологии; показания определяет оториноларинголог по данным эндоскопии и рентгенологического обследования. Плановые операции в сезон пыления причинных аллергенов не проводят.

Нетрадиционные методы

Гомеопатию, фитотерапию, гипноз, техники релаксации, ионизаторы воздуха и физиотерапию не рекомендуют: доказательств их пользы нет.

Иглоукалывание можно рассмотреть в составе комплексного лечения.

Дети, беременность, кормление грудью

С какого возраста можно детям

Мометазон и флутиказона фуроат разрешены с 2 лет, флутиказона пропионат — с 4 лет, беклометазон и будесонид — с 6 лет.

Цетиризин и дезлоратадин разрешены с 6 месяцев, лоратадин — с 2 лет. Антигистаминные первого поколения (хлоропирамин, диметинден) разрешены с 1 месяца, но, когда ребёнок дорастёт до нужного возраста, предпочтение отдают препаратам без седативного эффекта.

Монтелукаст в дозе 4 мг разрешён с 2 лет, в дозе 5 мг — с 6 лет.

АСИТ по инструкциям к препаратам проводят с 5 лет.

Назальные глюкокортикостероиды назначают детям в минимальной эффективной дозе, а при длительном применении следят за ростом.

Лучше ограничить препараты с высокой биодоступностью — будесонид (30–40%) и беклометазон (40–50%). У дексаметазона биодоступность больше 80%; это важно помнить, потому что он входит во многие комбинированные капли.

Беременность и кормление грудью

У беременных нужно помнить о рините беременных: заложенность носа без признаков инфекции и аллергии, которая полностью проходит в течение 2 недель после родов. Выявленная сенсибилизация говорит в пользу аллергического ринита.

Кожные пробы во время беременности и кормления не ставят; вместо них определяют специфические IgE в крови.

Предпочтение отдают ограничению контакта с аллергеном и промыванию носа. Лекарства назначают, если этого недостаточно, взвешивая риск для матери и ребёнка.

Доказательств риска для человека нет у лоратадина, цетиризина и будесонида (категория B по классификации FDA).

В первом триместре лекарства по возможности не назначают, если в них нет жизненной необходимости.

При кормлении грудью лучше ограничиться местными средствами с минимальной биодоступностью: все системные препараты проникают в молоко.

Контроль лечения

Визуальная аналоговая шкала — линия длиной 10 см, на которой пациент отмечает, насколько его беспокоят симптомы. Если отметка от 0 до 50 мм, ринит контролируется, если 50 мм и больше — не контролируется.

У подростков и взрослых при отметке 5 см и больше начинают с антигистаминных препаратов на 2–4 недели. Если ринит стал контролируемым, лечение продолжают по потребности и рассматривают АСИТ. Если нет, добавляют назальный глюкокортикостероид или монтелукаст ещё на 2–4 недели. Если и тогда контроля нет, пересматривают диагноз, ищут сопутствующую патологию, рассматривают АСИТ и хирургическое лечение.

Ринит считается контролируемым, если за последние 4 недели не было симптомов, не нарушались сон и дневная активность, а тест «дыхание с закрытым ртом» нормальный. Любое отклонение, в том числе более частая потребность в препаратах быстрой помощи, означает потерю контроля, и тогда можно переходить на ступень выше.

Для теста пациента просят закрыть рот и 30 секунд дышать только носом.

Для дневника симптомов (шкала TNSS) пациент каждый день оценивает чихание, водянистые выделения, заложенность и зуд от 0 до 3 баллов, сумма — от 0 до 12. Врач считает среднее за 7 дней. Дневник ведут в обострение и для оценки эффекта АСИТ.

Отдельно оценивают лекарства: только антигистаминные — 1 балл, назальные глюкокортикостероиды — 2, системные глюкокортикоиды — 3.

Наблюдение, профилактика, госпитализация

Каждому пациенту или его представителям объясняют суть болезни, составляют индивидуальный план лечения и учат управлять болезнью самостоятельно.

Пациенты находятся на диспансерном наблюдении у аллерголога-иммунолога или оториноларинголога: взрослые приходят не реже раза в год, дети — не реже двух раз в год. Наблюдение пожизненное или до стойкой ремиссии длительностью 3 года и больше.

АСИТ используют и для вторичной профилактики: она помогает предупредить астму, утяжеление ринита и расширение спектра сенсибилизации.

При пыльцевой сенсибилизации советуют ограничить перекрёстно-реагирующие продукты и растительные лекарства.

Лечат обычно амбулаторно. Госпитализируют при крайне тяжёлом или осложнённом течении, детей — при тяжёлом обострении с выраженной заложенностью, а также планово для ускоренного курса АСИТ. Выписывают, когда симптомы под контролем или курс АСИТ завершён.

Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Аллергический ринит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 11.07.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2027 года
Код в рубрикаторе	261_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

Неточности в самом тексте КР

- Разовая доза кромоглициевой кислоты указана в КР как «2.8 мкг», суточная — как «22.4 мкг». Сверьте с инструкцией в ГРЛС.
- Подпись к алгоритму в приложении Г1 гласит «пациентов, получавших лечение ранее», а в оригинальном названии — «untreated patients», то есть не получавших лечения.
- В тексте доз мометазона и флутиказона фуроата повторяются обрывки фраз; на смысл доз это не влияет.